REALIZAÇÃO
Sala de Situação de Saúde - UnB
Residência de Vigilância em Saúde

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO | PUBLICADO EM 27 DE OUTUBRO DE 2026

SE 42 2026

Semana Epidemiológica

18 a 24 de outubro de 2026

7 EIXOS TEMÁTICOS

31 ANÁLISES

RESUMO DA SEMANA

A SE 42 de 2026 foi marcada pela continuidade dos efeitos de eventos extremos sob o El Niño: o terremoto de magnitude 7,5 no Panamá deixou 22 unidades de saúde não operativas e 3.827 pessoas em abrigos, o furacão Simon atingiu a categoria 4 na costa do Pacífico mexicano e a cheia do rio Paraná levou à assistência de 220 famílias na fronteira com Foz do Iguaçu. A seca persiste em grande parte do país, inclusive em todo o Distrito Federal, e o PM2,5 supera 50 µg/m³ no Pará e no Amazonas. A SRAG segue estável no Brasil, com sinal de crescimento em Goiás, Mato Grosso e Sergipe, e os casos caem em todas as regiões de saúde do DF. A dengue soma 25.611 casos prováveis no país nas SE 38 a 41, e o DF acumula 3.596 casos prováveis no ano. Nas Américas, o sarampo chega a 56.978 casos e 83 óbitos, e o Peru registra casos em departamentos da fronteira com o Brasil; nenhuma região brasileira atinge a meta de cobertura da segunda dose. OPAS e SES-GO alertam para muito alto risco de reintrodução da poliomielite. A epidemia de doença pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo alcança 9.704 casos confirmados e chega ao Quênia e à Nigéria, e a França notifica o primeiro caso humano de infecção pelo vírus Shamonda no mundo.

NESTA EDIÇÃO

1 **Alerta ambiental** 2
6 análises | Risco 2

2 **Síndrome gripal e SRAG** 7
5 análises | Risco 2

3 **Cobertura vacinal** 12
2 análises | Risco 0

4 **Arboviroses e malária**
8 análises | Risco 2 14

5 **Sarampo** 21
6 análises | Risco 4

6 **Ebola** 27
3 análises | Risco 4

7 **Atualidades** 30
1 análise

1 Alerta ambiental

RISCO 2

Inundação, chuva, seca e queimada

Terremoto de magnitude 7,5 deixa 22 unidades de saúde não operativas no Panamá em outubro de 2026

7,5	26.018	3.827	22 de 219
magnitude do terremoto	pessoas afetadas	pessoas em 55 abrigos	unidades de saúde não operativas

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu o Panamá em 9 de outubro tem como principal desafio sanitário a perda de capacidade assistencial, e não a mortalidade imediata: na atualização de 23 de outubro, havia um óbito confirmado e 27 pessoas feridas. Dos 219 estabelecimentos de saúde avaliados pelo Ministério da Saúde do Panamá (Minsa), 22 estão com infraestrutura não operativa e 38 parcialmente operativos, e 30 mantêm o atendimento em espaços temporários ou adaptados; o Hospital Rural de Tonosí foi inabilitado. O Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc) contabiliza 26.018 pessoas diretamente afetadas, entre elas 85 gestantes e 1.026 pessoas com deficiência, e 3.827 pessoas em 55 abrigos ativos, concentradas em Veraguas (69,8%). O Minsa acompanha 908 eventos respiratórios e 473 entéricos e mantém vigilância reforçada para doenças respiratórias, gastrointestinais, dengue e outros eventos transmitidos por vetores e zoonoses. Dos 24 aquedutos rurais afetados em Soná e Mariato, 22 foram reativados, mas persistem dificuldades de acesso às tomadas de água de Malena e Furniales. (Figura 1)



Figura 1. Danos em edificação no Panamá após o terremoto de 9 de outubro de 2026 (foto: Reuters/Enea Lebrun)
Fonte: OPAS.

Furacão Simon atinge a categoria 4 e passa paralelo à costa do Pacífico do México em 11 de outubro de 2026

Categoria 4	240 km/h	16/10
pico de intensidade em 10 de outubro	ventos máximos	dissipação do sistema

O furacão Simon se formou no Pacífico e ganhou força de furacão entre 8 e 9 de outubro. A intensificação foi rápida, e o sistema chegou à categoria 4 no dia 10, com ventos de cerca de 240 km/h. Em 11 de outubro, o núcleo passou paralelo à costa oeste-central do México, próximo a Colima, Jalisco e Nayarit; depois permaneceu sobre o mar, com oscilações de intensidade, e se dissipou em 16 de outubro. Para a vigilância em saúde, os impactos esperados incluem traumas e afogamentos associados a ventos, ressaca e correntes de

retorno; leptospirose e doenças diarreicas agudas após inundações em áreas urbanas e rurais; aumento do risco de arboviroses pela água parada nas semanas seguintes; e deslizamentos provocados pela chuva em encostas, com risco para a população e para os serviços de saúde, de abastecimento de água e de energia. (Figura 2)

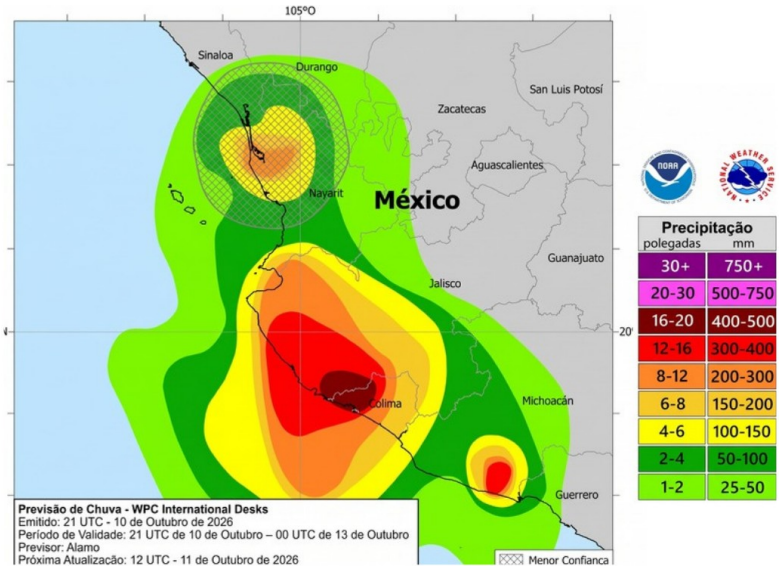


Figura 2. Previsão de chuva emitida em 10 de outubro de 2026 para as áreas afetadas pelo furacão Simon, México
Fonte: Unicef, OCHA e NOAA.

Cheia do rio Paraná atinge Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este (Paraguai), com 220 famílias assistidas até 19 de outubro de 2026

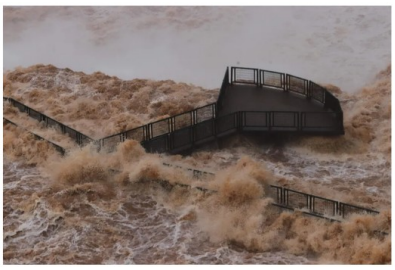
220
famílias assistidas em San Rafael (Paraguai), em 19/10

121,40 m
nível do rio ultrapassado no pico da cheia

116,80 m
nível do rio em 20/10

A cheia do rio Paraná, em outubro de 2026, provocou impactos em Foz do Iguaçu, no Brasil, e em Ciudad del Este, no Paraguai. Em 19 de outubro, 220 famílias haviam recebido assistência no bairro San Rafael, no lado paraguaio. O nível do rio, que ultrapassou 121,40 m no pico da cheia, recuou para 116,80 m em 20 de outubro, o que indica redução da água, mas não necessariamente o fim dos riscos, já que a previsão de chuvas intensas mantém a possibilidade de novas elevações. A situação reforça a importância do acompanhamento dos boletins hidrológicos, da permanência das famílias removidas em locais seguros até a liberação pelas autoridades e da prevenção de doenças e acidentes em áreas inundadas. (Figura 3)

A Passarelas das Cataratas do Iguaçu





B Ciudad del Este, Paraguai

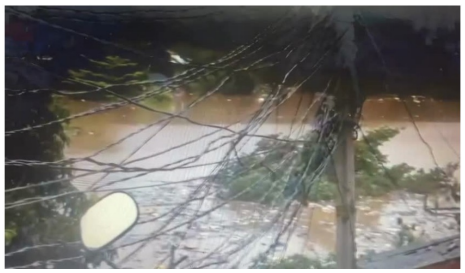


Figura 3. Cheia do rio Paraná nas Cataratas do Iguaçu e em Ciudad del Este (Paraguai), outubro de 2026
Fonte: Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Monitor de Secas registra seca em grande parte do Brasil e em todo o Distrito Federal em outubro de 2026

S2

seca grave em RR, no centro e sudoeste da Amazônia e na Bahia

Seca fraca

em todo o Distrito Federal, impactos de curto prazo

A seca atinge grande parte do território brasileiro, com predomínio da seca fraca e sem registro de seca extrema ou excepcional. As situações mais graves (seca grave, S2) se concentram no norte de Roraima, no centro e sudoeste da Amazônia e, principalmente, no oeste e centro da Bahia. A Região Sul permanece livre de seca, assim como áreas de Mato Grosso do Sul e do sul de Mato Grosso. No Distrito Federal não houve alteração em relação ao mapa anterior: todo o território segue com seca fraca e impactos de curto prazo. Apesar da menor intensidade, as condições ambientais no DF exigem atenção, pois podem contribuir para o agravamento de problemas respiratórios e de outros efeitos sobre a saúde da população. (Figura 4)

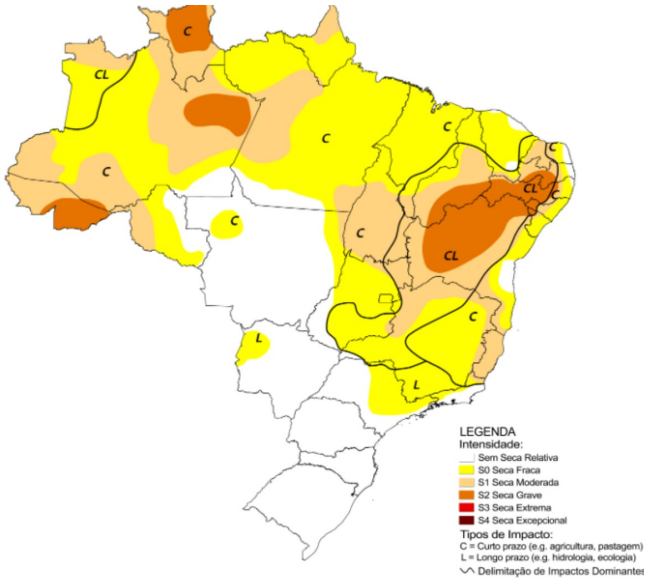


Figura 4. Intensidade e tipo de impacto da seca no Brasil, Monitor de Secas, elaborado em 16 de outubro de 2026

Fonte: Monitor de Secas (ANA).

Concentrações de PM2,5 superam 50 µg/m³ no centro-norte do Pará e no sul do Amazonas em outubro de 2026

> 50 µg/m³
PM2,5 no centro-norte do Pará e no sul do Amazonas

15 a 50 µg/m³
faixa moderada em MT, TO e partes de MA, PI e BA

A qualidade do ar piorou na Amazônia Legal e no Centro-Oeste, com concentrações elevadas de material particulado fino (PM2,5). Os níveis mais altos estão no centro-norte do Pará e no sul do Amazonas, acima de 50 µg/m³. Mato Grosso, Tocantins e partes do Maranhão, do Piauí e da Bahia estão na faixa moderada, entre 15 e 50 µg/m³, assim como uma mancha no interior de São Paulo e de Minas Gerais. O Sul, o litoral do Nordeste e o litoral do Sudeste apresentam boa qualidade do ar, abaixo de 15 µg/m³. A exposição a essas partículas pode agravar doenças respiratórias e cardiovasculares, sobretudo em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. (Figura 5)

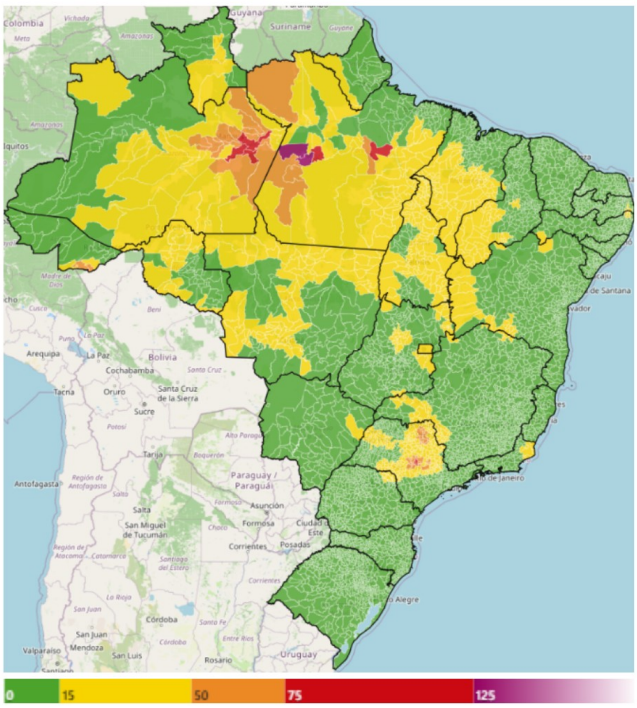


Figura 5. Concentração de material particulado fino (PM2,5) estimada pelo SISAM, Brasil, outubro de 2026
Fonte: SISAM/INPE.

Brasília registra média de PM2,5 de 9,5 µg/m³ entre 22 de setembro e 20 de outubro de 2026, sem dias insalubres

9,5 µg/m³
média de PM2,5 em Brasília no período

0
dias com qualidade do ar insalubre

Entre 22 de setembro e 20 de outubro, Brasília não registrou nenhum dia com qualidade do ar classificada como insalubre, e as concentrações de material particulado fino (PM2,5) permaneceram, em geral, em níveis satisfatórios. Ainda assim, a concentração média foi de 9,5 µg/m³, com aumento em relação aos meses anteriores de 2026. O valor fica abaixo da diretriz diária da Organização Mundial da Saúde (15 µg/m³), mas quase dobra a referência anual (5 µg/m³). Não existe limiar seguro para o material particulado fino: o dano decorre também da exposição prolongada a concentrações moderadas, e não apenas dos picos. Pessoas com asma, crianças e idosos são os primeiros a sentir o efeito, com mais crises e atendimentos. Sob o El Niño, a combinação de calor, baixa umidade e incêndios no Cerrado e na Amazônia favorece o transporte de fumaça a longas distâncias, e as concentrações podem subir nas próximas semanas. (Figura 6)

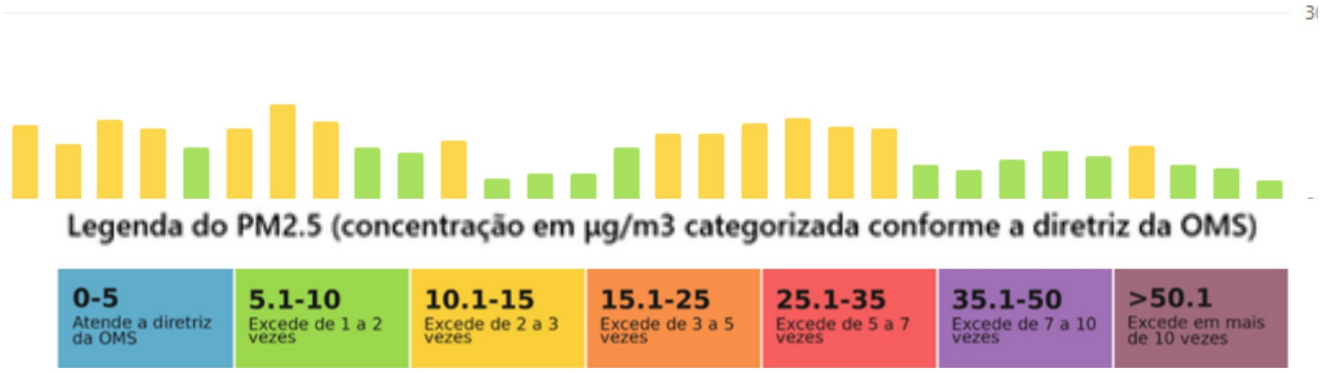


Figura 6. Concentração diária de PM2,5, Brasília (DF), 22 de setembro a 20 de outubro de 2026
Fonte: IQAir.

2 Síndrome gripal e SRAG

RISCO 2
Humanos

Vigilância sentinela de síndrome gripal identifica 46.524 vírus respiratórios no Brasil até a SE 41 de 2026

46.524	60%	45%	37%
vírus respiratórios identificados	rinovírus entre os outros vírus	influenza B entre os casos de influenza	influenza A(H3N2) entre os casos de influenza

A vigilância sentinela de síndrome gripal identificou 46.524 vírus respiratórios no Brasil até a SE 41 de 2026. Do total, 70% correspondem a outros vírus respiratórios e 30% à influenza. Entre os outros vírus, o rinovírus segue como o mais detectado (60%), seguido pelo vírus sincicial respiratório (VSR, 16%). Entre os casos de influenza, a influenza B responde por 45% e a influenza A(H3N2) por 37%. Ao longo do ano, o rinovírus foi o vírus mais frequente em todas as semanas. A influenza A(H3N2) teve maior peso no início do ano, com pico entre as SE 9 e 11, e depois perdeu espaço. A influenza B ganhou destaque a partir da SE 19, manteve alta circulação até cerca da SE 28 e vem diminuindo desde então. O VSR aumentou entre as SE 19 e 26 e segue em queda. O SARS-CoV-2 manteve baixa detecção em todo o período. Nas últimas semanas há redução geral das detecções, sobretudo nas SE 40 e 41, que ainda devem ser atualizadas e por isso precisam ser interpretadas com cautela. (Figura 7)

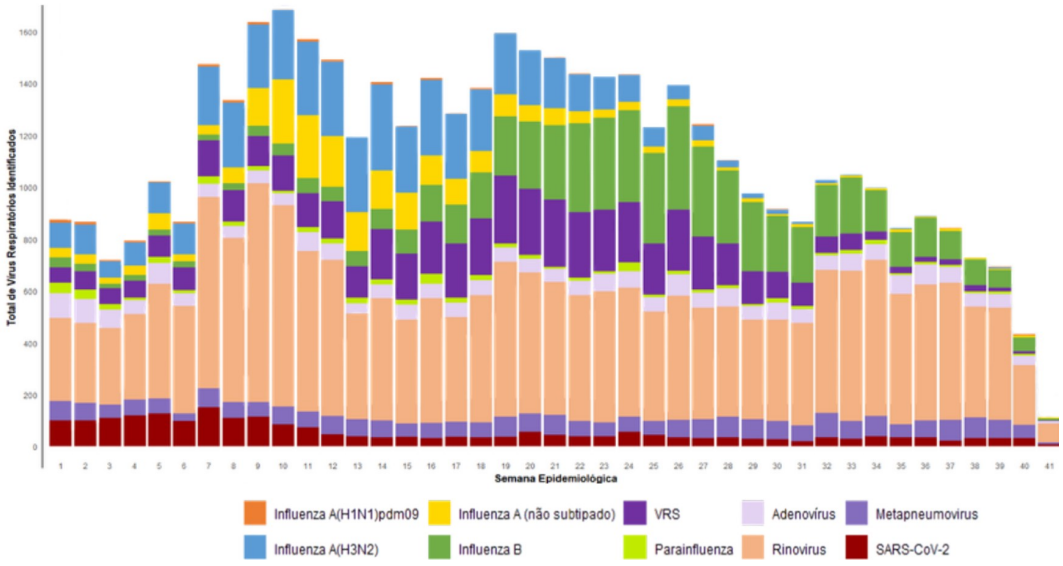


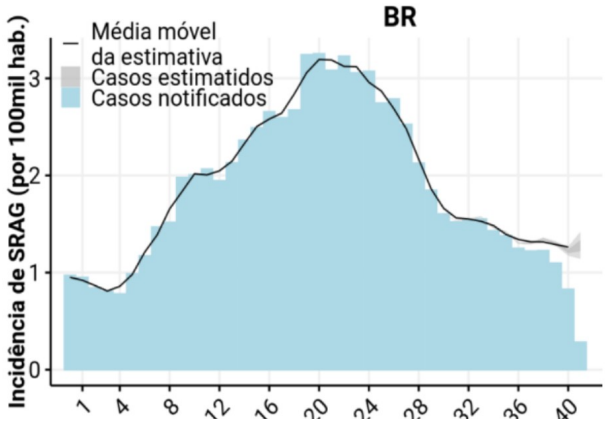
Figura 7. Vírus respiratórios identificados na vigilância sentinela de síndrome gripal, por SE, Brasil, 2026 até a SE 41
Fonte: Ministério da Saúde.

InfoGripe aponta estabilidade da SRAG no Brasil até a SE 41 de 2026, com sinal de crescimento em Goiás, Mato Grosso e Sergipe

3,2	1,3	3 UF
casos por 100 mil hab. no pico, SE 20 a 22	casos por 100 mil hab. desde a SE 32	com sinal de crescimento: GO, MT e SE

A incidência semanal de SRAG no Brasil está em queda desde o pico ocorrido entre as SE 20 e 22, quando chegou a cerca de 3,2 casos por 100 mil habitantes. Desde aproximadamente a SE 32, a incidência se mantém estável, em torno de 1,3 caso por 100 mil habitantes, e a redução observada nas SE 40 e 41 deve ser vista com cautela, pois ainda sofre o efeito do atraso de notificação. Por faixa etária, os menores de 2 anos concentram o maior número de casos, hoje em torno de 1.000 por semana; as demais faixas mostram queda ou estabilidade, com leve aumento em crianças de 2 a 4 e de 5 a 14 anos por volta das SE 32 a 34. Três estados apresentam incidência de SRAG com sinal de crescimento: Goiás, Mato Grosso e Sergipe. (Figura 8)

A Incidência semanal de SRAG



B Casos novos de SRAG por faixa etária

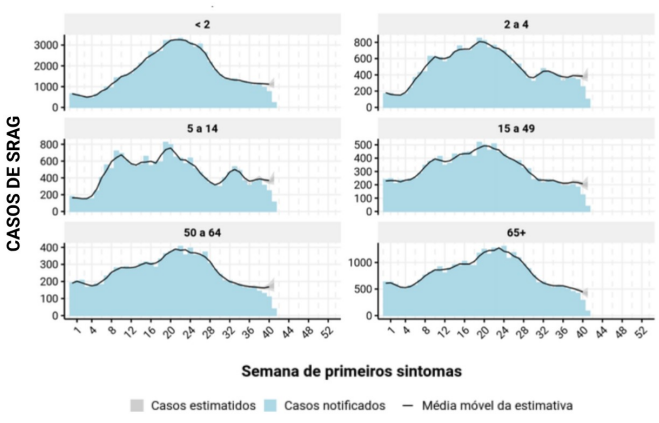


Figura 8. Incidência semanal de SRAG e casos novos por faixa etária, Brasil, 2026 até a SE 41
Fonte: InfoGripe (Fiocruz).

Brasil registra 6.977 óbitos por SRAG entre 160.632 casos confirmados até a SE 41 de 2026

160.632	6.977
casos de SRAG confirmados	óbitos por SRAG
alta de 1,8%	alta de 1,8%

Até a SE 41 de 2026, o Brasil registrou 6.977 óbitos por SRAG entre 160.632 casos confirmados. Em relação à semana anterior, os casos e os óbitos aumentaram 1,8%. A mortalidade se concentra nas pessoas com 65 anos ou mais, que respondem por grande parte das detecções virais em óbitos, com destaque para influenza A, rinovírus e covid-19, enquanto nos menores de 2 anos predominam o VSR e o rinovírus. (Figura 9)

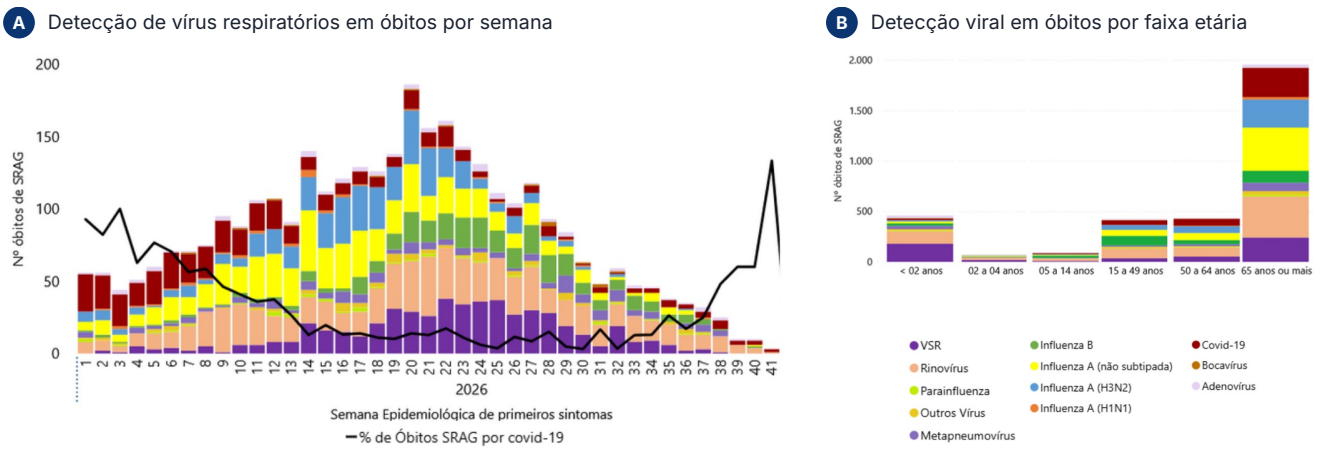


Figura 9. Óbitos por SRAG e detecção de vírus respiratórios em óbitos, Brasil, até a SE 41 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Vigilância sentinela do Distrito Federal registra aumento discreto de SARS-CoV-2 entre as SE 36 e 41 de 2026

50 (100%)	27 (69%)	4 (50%)
amostras processadas na SE 40	amostras processadas na SE 41	amostras processadas na SE 42

No Distrito Federal, a distribuição percentual dos vírus respiratórios causadores de síndrome gripal identificados pela vigilância sentinela até a SE 41 de 2026 mostra padrão relativamente estável ao longo do ano. O rinovírus segue como o vírus mais identificado em praticamente todas as semanas, seguido pela influenza B, que ganhou destaque a partir da SE 17 e se mantém presente, e pela influenza A não subtipada. O VSR e o adenovírus aparecem em menor proporção. O metapneumovírus, que teve participação importante até cerca da SE 13, ainda não voltou a aumentar. Já o SARS-CoV-2 aumentou de forma discreta nas últimas semanas, com participação maior entre as SE 36 e 41, ainda que a proporção possa oscilar pelo pequeno número de amostras. Na SE 40 foram coletadas e processadas 50 amostras (100%); na SE 41, 39 coletadas e 27 processadas (69%); e na SE 42, 8 coletadas e 4 processadas (50%). As semanas mais recentes ainda serão atualizadas, pois o processamento das amostras não foi concluído. (Figura 10)

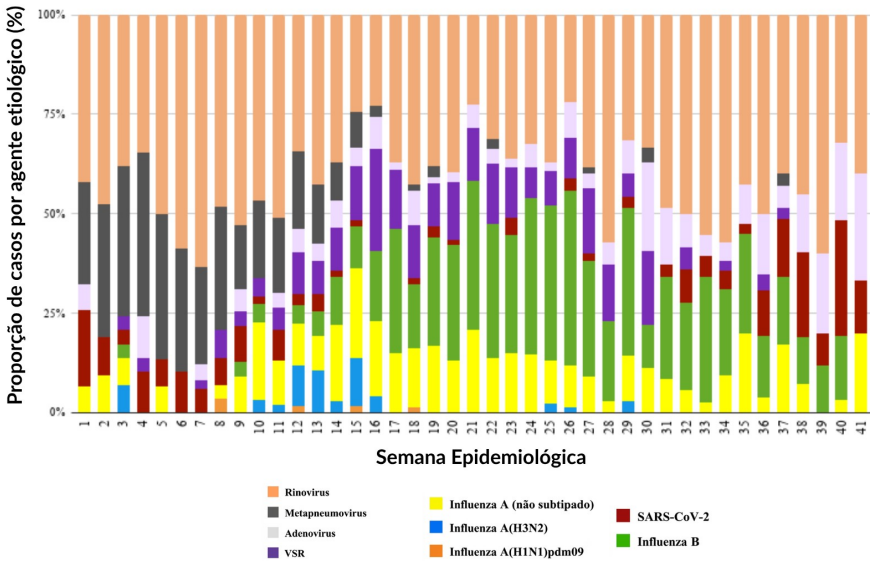


Figura 10. Distribuição dos vírus identificados pela vigilância sentinela do Distrito Federal, por SE, 2026
Fonte: SIVEP-Gripe.

Casos de SRAG caem em todas as regiões de saúde do Distrito Federal nas SE 38 a 41 de 2026

64
casos na Região Oeste, a maior do DF
queda de 9,8%

42,8%
maior queda, na Região Leste

Os casos de SRAG apresentaram queda em todas as regiões de saúde do Distrito Federal entre as SE 38 e 41, em comparação com o intervalo das SE 37 a 40. A Região Oeste segue com o maior número de casos nas últimas quatro semanas, 64, com queda de 9,8%, seguida da Região Sudoeste (63 casos, queda de 13,7%) e da Região Centro-Sul (48 casos, queda de 14,2%). As maiores reduções percentuais ocorreram nas regiões Leste (42,8%) e Central (21,4%), e a menor, na Região Norte (6,6%). Esses números ainda podem aumentar, pois a notificação tem atraso natural: o agravamento da síndrome gripal costuma ocorrer algum tempo depois dos primeiros sintomas. (Figura 11; Tabela 1)

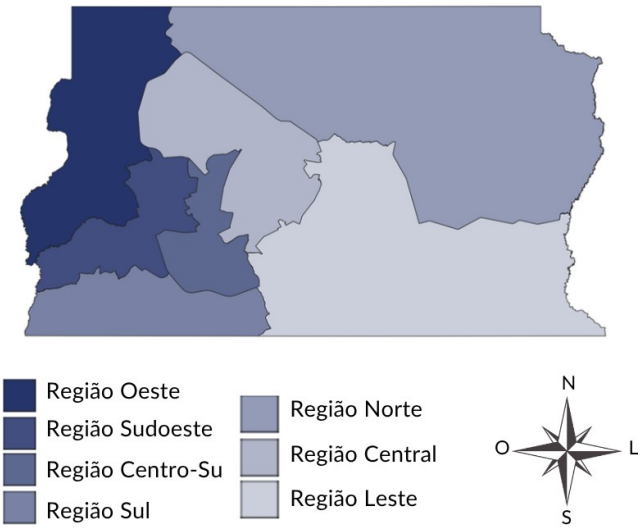


Figura 11. Casos de SRAG por região de saúde do Distrito Federal, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: SIVEP-Gripe.

Tabela 1. Casos de SRAG por região de saúde, Distrito Federal, SE 38 a 41 de 2026

REGIÃO DE SAÚDE	SE 38	SE 39	SE 40	SE 41	TOTAL	VARIAÇÃO*
Oeste	16	21	14	13	64	queda de 9,8%
Sudoeste	20	20	11	12	63	queda de 13,7%
Centro-Sul	12	17	13	6	48	queda de 14,2%
Sul	11	6	10	5	32	queda de 15,7%
Norte	8	10	7	3	28	queda de 6,6%
Central	5	8	6	3	22	queda de 21,4%
Leste	8	4	4	0	16	queda de 42,8%

*Em relação às SE 37 a 40.

3 Cobertura vacinal

RISCO 0
Humanos

Cobertura vacinal contra influenza em crianças e idosos fica abaixo da meta no DF e na RIDE-DF em 2026

90%
meta de cobertura para os grupos prioritários

41% a 60%
cobertura em crianças e idosos no Distrito Federal

> 80%
cobertura em gestantes no Distrito Federal

A cobertura vacinal contra a influenza em 2026 no Distrito Federal e nos municípios da RIDE-DF permanece abaixo da meta de 90% definida pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários na maior parte do território. Em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, nenhum município alcança 80%: predominam coberturas entre 41% e 60%, inclusive no Distrito Federal, e há municípios na faixa de 21% a 40%, concentrados nas porções oeste e central da região. A necessidade de duas doses na primovacinação contribui para esquemas incompletos nessa faixa etária. Entre os idosos, o cenário é o mais desfavorável: a maioria dos municípios, sobretudo no norte e no centro da região, registra coberturas entre 21% e 40%, e o Distrito Federal está entre 41% e 60%. O dado é relevante porque os idosos concentram a maior carga de hospitalizações e óbitos por influenza e, historicamente, apresentavam maior adesão à vacinação. Nas gestantes, a situação é mais favorável e heterogênea, com vários municípios acima de 95% e o Distrito Federal acima de 80%; coberturas muito elevadas nesse grupo devem ser interpretadas com cautela, pois o denominador é estimado a partir dos nascidos vivos e pode subestimar a população-alvo. A coexistência de municípios com baixa cobertura favorece bolsões de suscetíveis em uma região de intensa mobilidade pendular com o Distrito Federal. (Figura 12)

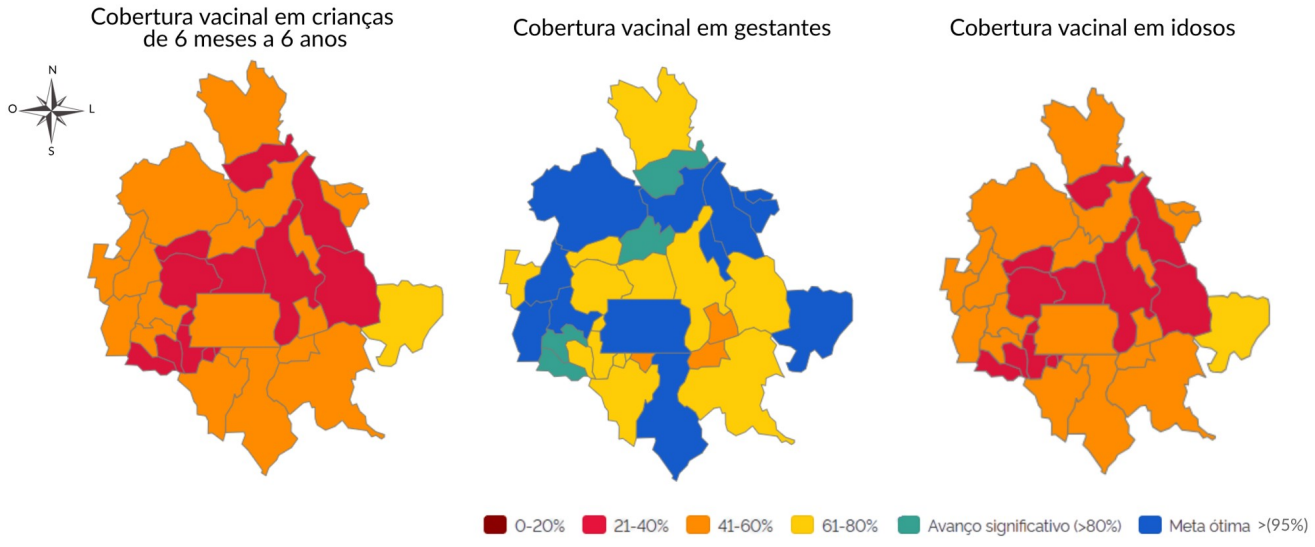


Figura 12. Cobertura vacinal contra influenza em crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos, DF e RIDE-DF, 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

OPAS e SES-GO alertam para muito alto risco de reintrodução da poliomielite no Brasil em outubro de 2026

35 anos	87%	0,85	48
sem poliovírus selvagem nas Américas	cobertura da 3ª dose de VIP nas Américas em 2025	caso de PFA por 100 mil menores de 15 anos	casos de poliovírus selvagem tipo 1 no mundo em 2026
	meta de 95%	meta de pelo menos 1	

Em outubro de 2026, durante as mobilizações do Dia Mundial de Combate à Poliomielite, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) alertaram para o risco de reintrodução da doença no Brasil. Embora as Américas completem 35 anos sem casos de poliomielite causados pelo poliovírus selvagem (o último ocorreu no Peru, em 1991), a cobertura regional com a vacina inativada (VIP) permanece abaixo da meta de 95%, com 91% na primeira dose, 89% na segunda e 87% na terceira em 2025. A taxa de notificação de paralisia flácida aguda (PFA) foi de 0,85 caso por 100 mil menores de 15 anos, abaixo da meta de pelo menos 1. A circulação do poliovírus selvagem tipo 1 no Afeganistão e no Paquistão, com 48 casos em 2026, mantém o risco de importação, especialmente em populações com baixa cobertura vacinal. No Brasil, sem casos desde 1989, as avaliações nacionais classificam o país como de muito alto risco para a reintrodução, principalmente pelas baixas coberturas e por fragilidades nos indicadores de vigilância. Nesse cenário, Goiás reforça a vigilância da PFA, com notificação de todo caso em menores de 15 anos em até 24 horas, investigação epidemiológica, coleta oportuna de fezes para o Lacen-GO e investigação de adolescentes e adultos com quadro compatível. O fortalecimento da vacinação de rotina e da vigilância é essencial para detectar precocemente a circulação viral.

Fonte: OPAS/OMS e SES-GO.

4 Arboviroses e malária

RISCO 2
Humanos

Brasil registra 25.611 casos prováveis de dengue e 1 óbito entre as SE 38 e 41 de 2026

25.611	264	1
casos prováveis	casos graves e com sinais de alarme	óbito confirmado, 30 em investigação
queda de 5,7%		queda de 50%

Entre as SE 38 e 41 de 2026, o Brasil registrou 25.611 casos prováveis de dengue, incidência de 12,0 por 100 mil habitantes, redução de 5,7% em relação às SE 37 a 40. Os casos graves e com sinais de alarme somaram 264, com um óbito confirmado e 30 em investigação, o que resulta em letalidade de 0,38% entre os casos graves. Goiás e Espírito Santo apresentam as maiores incidências do país, enquanto São Paulo, Goiás e Minas Gerais concentram o maior volume absoluto de casos. A SE 41 ainda está incompleta por atraso de notificação, e parte da redução observada tende a ser revista. (Figura 13)

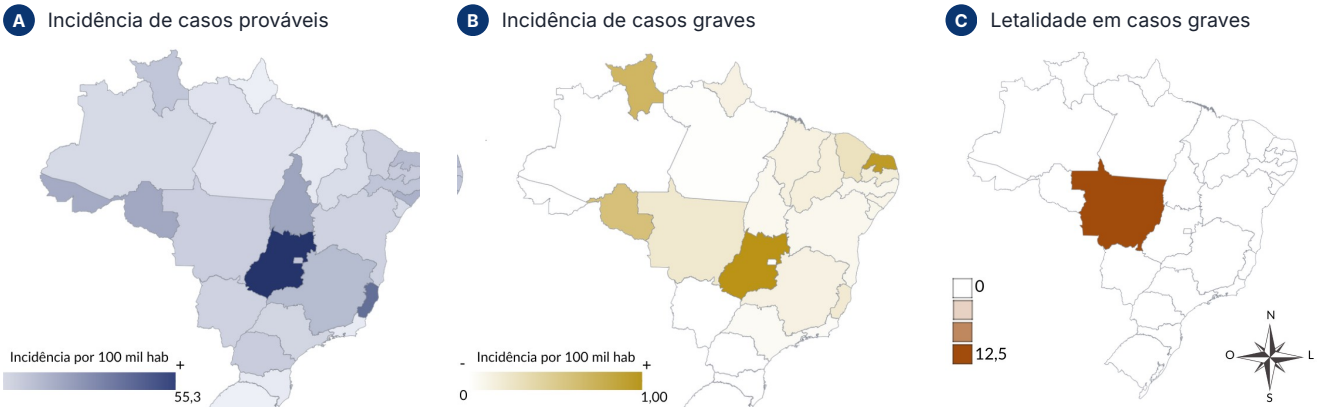


Figura 13. Incidência de casos prováveis e de casos graves de dengue e letalidade em casos graves por UF, Brasil, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Goiás registra 6.264 casos prováveis de dengue nas SE 38 a 41 de 2026, com maior incidência no município de Panamá

6.264
casos prováveis
queda de 1,5%

84
casos por 100 mil hab.

170 mil
notificações no ano, 17% acima de 2025

Em Goiás, entre as SE 38 e 41 de 2026, foram registrados 6.264 casos prováveis de dengue, incidência de 84 por 100 mil habitantes, estável em relação às quatro semanas anteriores (queda de 1,5%). As maiores incidências ocorrem em municípios de pequeno porte, como Panamá, com 658 por 100 mil, e Campestre de Goiás, com 541, onde poucos casos elevam o indicador. Mineiros e Bela Vista de Goiás combinam incidência acima de 400 por 100 mil com volume absoluto expressivo, de 318 e 156 casos. No acumulado das SE 1 a 42, o estado soma cerca de 170 mil notificações, 17% acima do mesmo período de 2025. (Figura 14; Tabela 2)

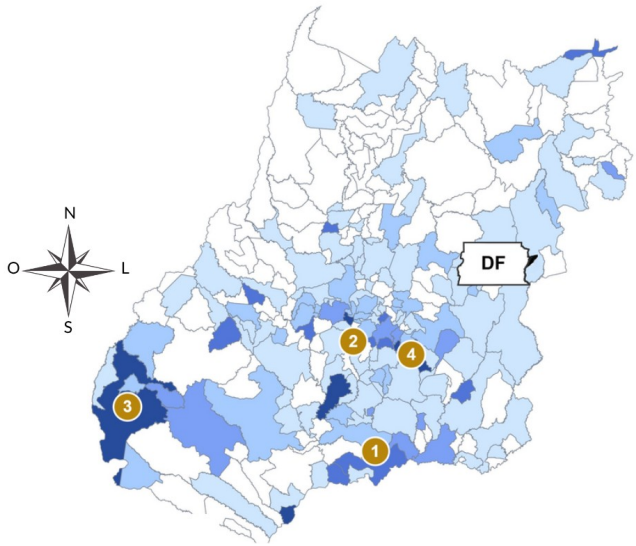


Figura 14. Incidência de casos prováveis de dengue por município, Goiás, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: SES-GO.

Tabela 2. Municípios de Goiás com maior incidência de casos prováveis de dengue, SE 38 a 41 de 2026

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	CASOS PROVÁVEIS	POR 100 MIL HAB.
Panamá	2.432	16	658
Campestre de Goiás	3.879	21	541
Mineiros	74.999	318	424
Bela Vista de Goiás	37.305	156	418

Distrito Federal acumula 3.596 casos prováveis de dengue em 2026, sem óbitos, até a SE 41

3.596	232	16	0
casos prováveis	casos confirmados	casos com sinais de alarme	óbitos
alta de 1,9%	alta de 10%		

No Distrito Federal, até a SE 41 de 2026, foram registrados 3.596 casos prováveis de dengue, aumento de 1,9% em relação ao informe anterior. Do total, 232 foram confirmados, 16 com sinais de alarme, sem casos graves nem óbitos. As maiores incidências acumuladas estão nas regiões de saúde Leste, Sul e Oeste, todas acima de 138 casos por 100 mil habitantes, enquanto a Região Central registra 30,6. Dos 17.683 exames de RT-PCR realizados, 133 foram positivos (positividade de 0,8%), com predomínio do sorotipo DENV-3, seguido do DENV-2; 20 desses casos tiveram relação temporal com a vacina atenuada. (Figura 15)

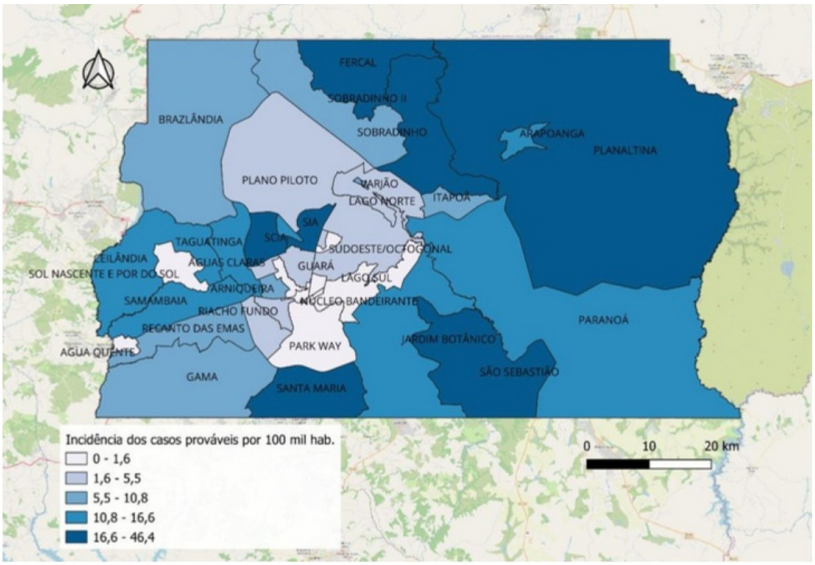


Figura 15. Incidência de casos prováveis de dengue por região administrativa, Distrito Federal, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: SES-DF.

Brasil registra 2.607 casos prováveis de chikungunya nas SE 38 a 41 de 2026, com alta em Mato Grosso do Sul

2.607
casos prováveis
queda de 14,4%

16,5
casos por 100 mil hab. em Mato Grosso do Sul
alta de 15,3%

Entre as SE 38 e 41 de 2026, o Brasil registrou 2.607 casos prováveis de chikungunya, incidência de 1,2 por 100 mil habitantes, redução de 14,4% em relação às SE 37 a 40, sem óbitos confirmados e com um óbito em investigação em Pernambuco. Mato Grosso do Sul mantém a maior incidência do país, 16,5 por 100 mil, e foi a única unidade federada entre as de maior incidência com aumento no período, de 15,3%. A Bahia concentra o maior volume absoluto, com 562 casos, e, assim como Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, apresentou queda. Parte da redução reflete o atraso de notificação da SE 41. (Figura 16; Tabela 3)

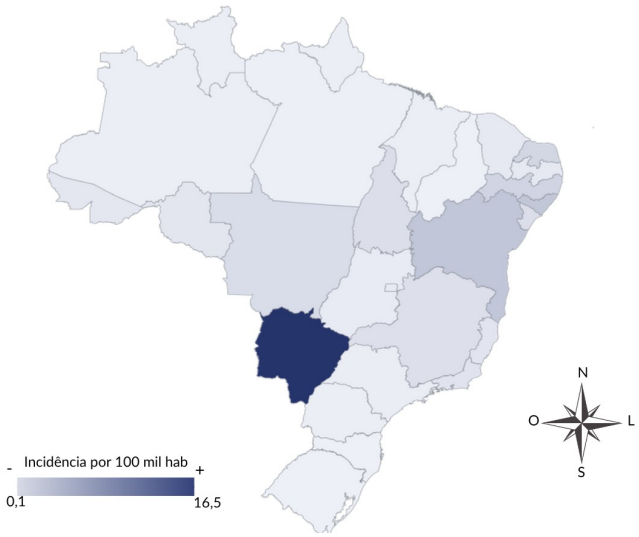


Figura 16. Coeficiente de incidência de casos prováveis de chikungunya por UF, Brasil, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Tabela 3. Estados com maior incidência de casos prováveis de chikungunya, SE 38 a 41 de 2026

UF	CASOS PROVÁVEIS	POR 100 MIL HAB.	VARIAÇÃO*
Mato Grosso do Sul	482	16,5	alta de 15,3%
Bahia	562	3,8	queda de 19,9%
Alagoas	115	3,6	queda de 47,0%
Pernambuco	238	2,5	queda de 23,7%
Rio Grande do Norte	78	2,3	queda de 17,0%

*Em relação às SE 37 a 40.

Distrito Federal registra 261 casos prováveis de chikungunya em 2026 até a SE 41

261	203	58	0
casos prováveis	casos confirmados	casos em investigação	óbitos
6 casos a mais	1 caso a mais	5 casos a mais	

No Distrito Federal, até a SE 41 de 2026, foram registrados 261 casos prováveis de chikungunya, seis a mais que no informe anterior, com incidência acumulada de 4 casos por 100 mil habitantes. Desses, 203 foram confirmados por critério laboratorial e 58 permanecem em investigação, sem óbitos registrados. A Região Sul apresenta a maior incidência acumulada, 24,3 por 100 mil, seguida da Região Central, com 12,8. Dos 10.344 exames de RT-PCR processados, 79 foram positivos (positividade de 0,8%), na estratégia multiplex que identifica dengue, chikungunya e Zika na mesma amostra. (Figura 17)

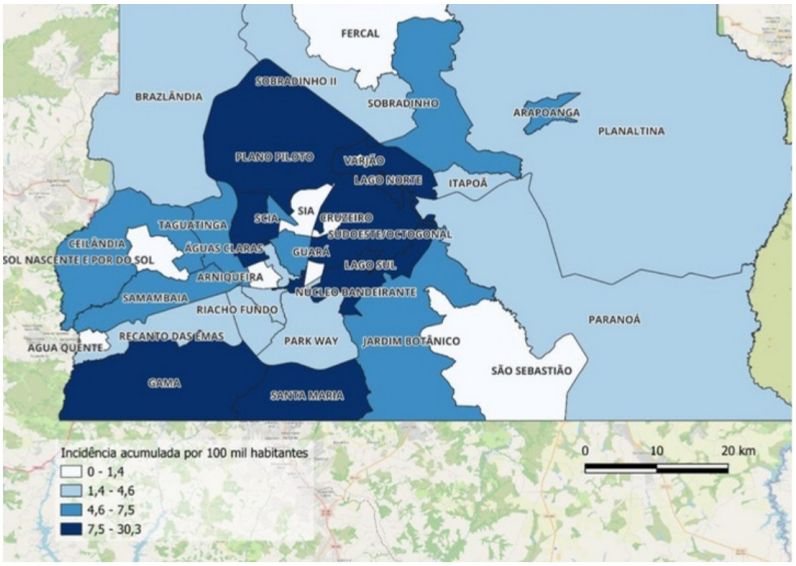


Figura 17. Incidência acumulada de casos prováveis de chikungunya por região administrativa, Distrito Federal, até a SE 41 de 2026
Fonte: SES-DF.

RIDE-DF registra 377 casos prováveis de dengue nas SE 38 a 41 de 2026, com Unaí (MG) em destaque

377	12.294	6	209
casos prováveis de dengue nas SE 38 a 41	casos prováveis de dengue em 2026	casos prováveis de chikungunya nas SE 38 a 41	casos prováveis de chikungunya em 2026
queda de 20,6%		queda de 25%	alta de 0,5%

Nos 33 municípios da RIDE-DF, excluído o Distrito Federal, foram notificados 377 casos prováveis de dengue entre as SE 38 e 41 de 2026, redução de 20,6% em relação às SE 37 a 40, e 12.294 casos no acumulado do ano. Unaí (MG) concentra o maior volume, com 93 casos, e a maior incidência da região, 107,1 por 100 mil habitantes, seguido de Novo Gama (GO), com 43 casos, e Luziânia (GO), com 38. A chikungunya mantém circulação baixa, com seis casos no período, distribuídos entre Goianésia, Unaí e Luziânia, e 209 casos acumulados em 2026. (Figura 18)

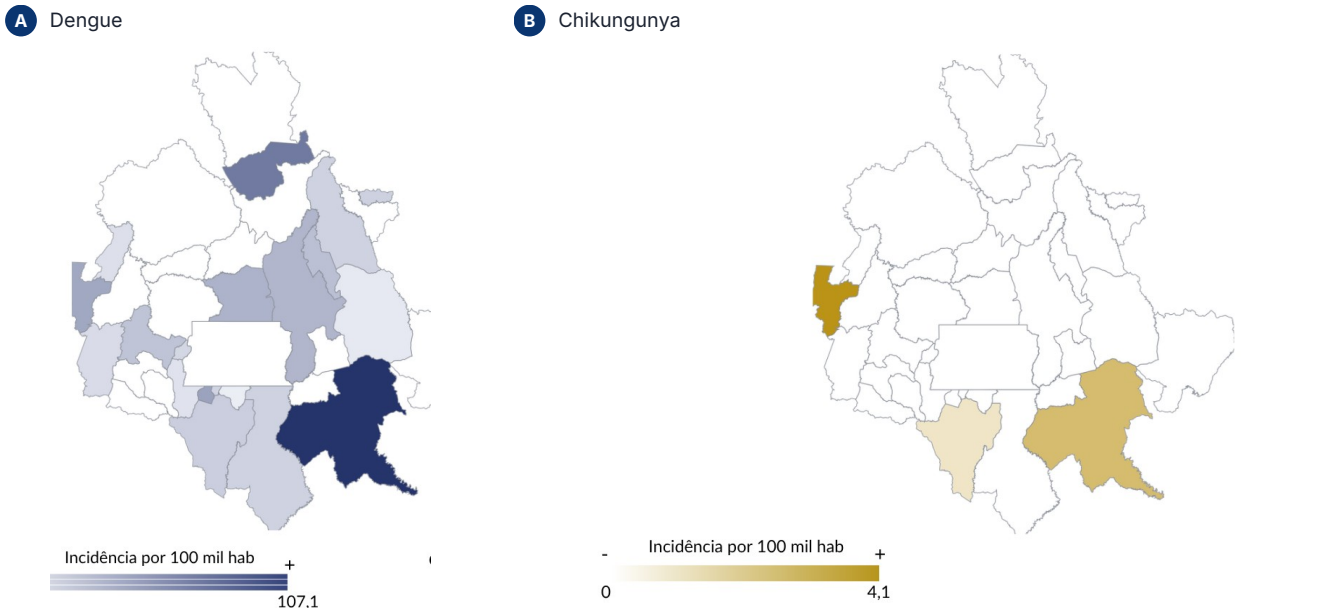


Figura 18. Incidência de casos prováveis de dengue e de chikungunya na RIDE-DF, SE 38 a 41 de 2026
Fonte: InfoDengue.

Região Amazônica acumula 76.285 casos de malária em 2026 até a SE 41, com Jacareacanga (PA) como maior foco

76.285	76.258	78.643	2.683
casos em 2026	por local provável de infecção	por local de notificação	casos com infecção em outros países
alta de 2,3%	alta de 2,3%	alta de 2,3%	alta de 3,3%

Até a SE 41 de 2026, a Região Amazônica registrou 76.285 casos de malária. Por local provável de infecção foram contabilizados 76.258 casos e, por local de notificação, 78.643; outros 2.683 casos tiveram infecção em outros países. Todos os indicadores cresceram cerca de 2,3% em relação à SE 40. Entre os municípios com mais casos por local provável de infecção estão Jacareacanga (PA), com 9.695, Manaus (AM), Alto Alegre (RR), Porto Velho (RO), Calçoene (AP), Cruzeiro do Sul (AC) e Colniza (MT). Por local de notificação, também se destacam Jacareacanga, Manaus, Porto Velho, Alto Alegre, Calçoene, Cruzeiro do Sul e Colniza. A série histórica de 2007 a 2026 permite acompanhar a evolução dos registros na região. (Figura 19; Tabela 4)

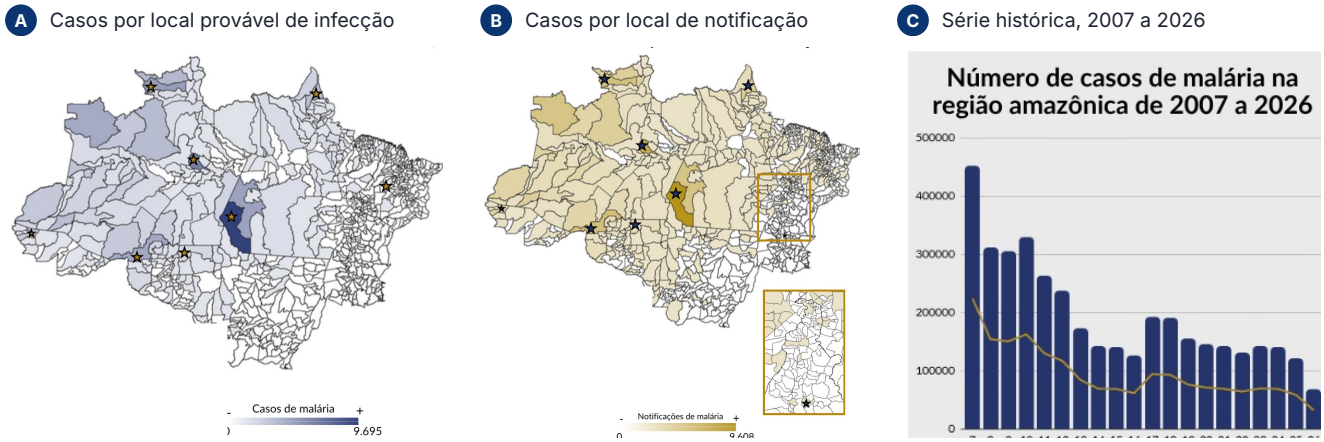


Figura 19. Situação epidemiológica da malária na Região Amazônica, 2026 até a SE 41
Fonte: Ministério da Saúde.

Tabela 4. Municípios com mais casos de malária por local provável de infecção, Região Amazônica, 2026 até a SE 41

UF	MUNICÍPIO	CASOS
PA	Jacareacanga	9.695
AM	Manaus	5.737
RR	Alto Alegre	4.189
RO	Porto Velho	3.472
AP	Calçoene	2.245
AC	Cruzeiro do Sul	1.586
MT	Colniza	663
MA	Santa Luzia	4

Região Extra-Amazônica registra 27 casos de malária por local provável de infecção e 326 notificações em 2026 até a SE 41

27
casos por local provável de infecção

326
notificações
alta de 1,2%

Até a SE 41 de 2026, a Região Extra-Amazônica registrou 27 casos de malária por local provável de infecção e 326 casos por local de notificação, alta de 1,2% nas notificações em relação à SE 40. A diferença entre os dois indicadores mostra que parte dos casos notificados na região teve infecção em outras localidades, o que exige distinguir o local provável de infecção do local de registro. Os casos por local provável de infecção estão distribuídos por municípios de diferentes estados, e as notificações abrangem diversas áreas do território extra-amazônico. A série histórica de 2007 a 2026 contextualiza os dados atuais. O monitoramento desses casos é importante para identificar ocorrências importadas, acompanhar a distribuição territorial da doença e orientar as ações de vigilância. (Figura 20)

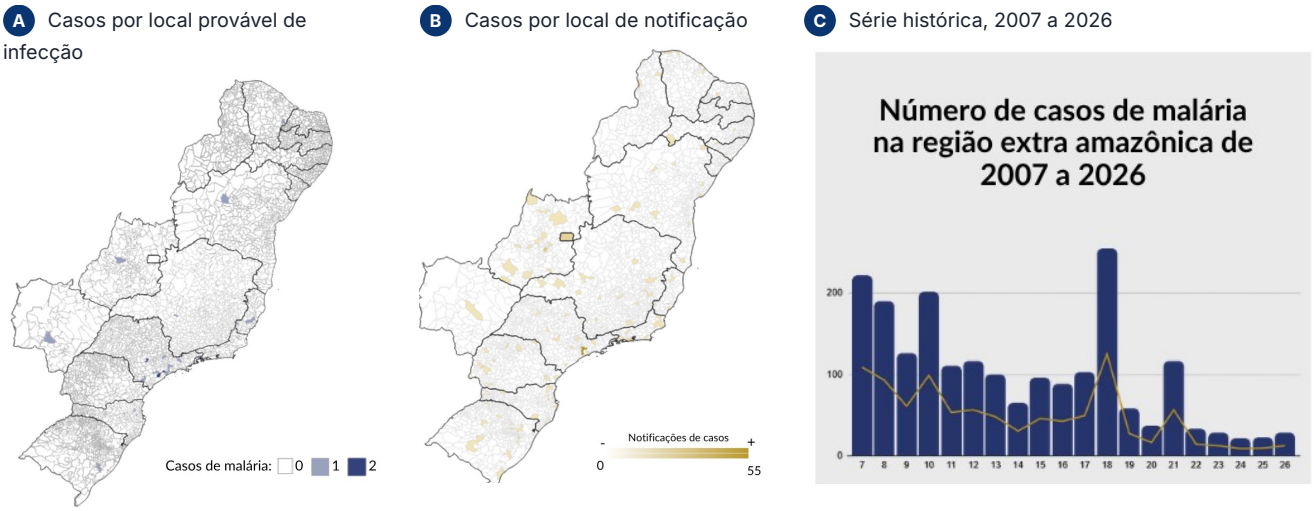


Figura 20. Situação epidemiológica da malária na Região Extra-Amazônica, 2026 até a SE 41
Fonte: Ministério da Saúde.

5 Sarampo

RISCO 4

Humanos e primatas não humanos

Região das Américas acumula 56.978 casos de sarampo e 83 óbitos em 2026 até a SE 41

56.978	83	61%
casos confirmados em 2026	óbitos, letalidade de 0,15%	dos casos na Guatemala

A Região das Américas soma 56.978 casos confirmados de sarampo e 83 óbitos em 2026. Segundo a OPAS, o número de casos é 4,8 vezes maior que o do mesmo período de 2025. A carga é concentrada: a Guatemala responde por 61% dos casos e 64% dos óbitos e, somada ao México, por 85% do total regional; com Estados Unidos, Peru e Canadá, cinco países reúnem mais de 99% dos casos. O coeficiente de incidência acompanha essa concentração, com os valores mais altos na Guatemala, acima de 20 casos por 100 mil habitantes, seguida por México e Peru, entre 5 e 20; no Brasil, a incidência permanece inferior a 1 caso por 100 mil. A letalidade regional é de 0,15%. Oito países tiveram casos entre as SE 38 e 41: Guatemala, México, Estados Unidos, Peru, Canadá, Bolívia, Brasil e Colômbia. Em El Salvador, Honduras, Belize, Panamá e Costa Rica, o último caso ocorreu entre as SE 15 e 31. O contexto é de perda do status de eliminação: em novembro de 2025, a OPAS anunciou que as Américas deixaram de ser região livre do sarampo após o restabelecimento da transmissão endêmica no Canadá. Em 2025, a cobertura regional foi de 88% na primeira dose e 85% na segunda, abaixo dos 95% necessários, e a OPAS classifica como muito alto o risco de disseminação diante de eventos religiosos de massa previstos na América do Sul. (Figura 21; Tabela 5)

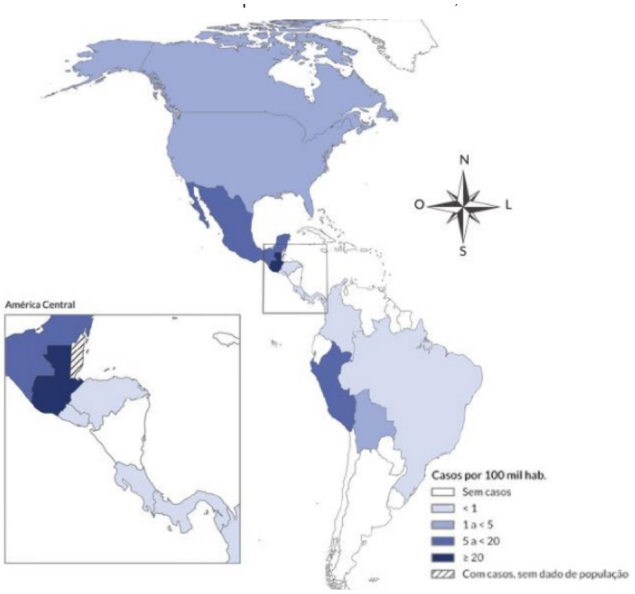


Figura 21. Casos acumulados confirmados de sarampo e coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, Região das Américas, SE 1 a 41 de 2026

Fonte: OPAS, CDC, PA DOH, DGE/SSA, Minsa/DGE, PHAC, MSPAS, Minsalud e Ministério da Saúde.

Tabela 5. Casos confirmados e óbitos por sarampo na Região das Américas, 2026

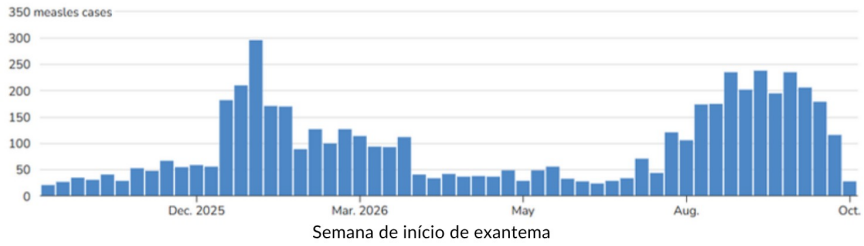
PAÍS	CONFIRMADOS	ÚLTIMA SE	ÓBITOS
Guatemala	34.535	41	53
México	13.718	40	23
Estados Unidos	4.588	41	5
Peru	2.709	40	1
Canadá	1.124	40	0
Bolívia	120	39	1
Brasil	61	40	0
El Salvador	58	30	0
Colômbia	16	38	0
Honduras	15	31	0
Belize	15	31	0
Panamá	9	23	0
Costa Rica	5	15	0
Outros	5		0
Total	**56.978**		**83**

Estados Unidos acumulam 4.588 casos de sarampo em 2026 até 22 de outubro, o dobro do total de 2025

4.588	3	47
casos confirmados **alta de 4,4% (178 casos)**	óbitos confirmados pelo CDC	jurisdições com casos

Os Estados Unidos registram 4.588 casos confirmados de sarampo em 2026 até 22 de outubro, segundo o CDC, mais que o dobro dos 2.289 casos de 2025 e mais de 15 vezes o total de 2024. Há casos em 47 jurisdições, e 96% estão associados a surtos, incluindo 1.384 casos vinculados a surtos iniciados em 2025, o que evidencia a continuidade da transmissão entre os anos. A curva semanal por início do exantema mostra duas ondas: a primeira, com pico próximo de 300 casos em janeiro, e a segunda, iniciada em julho, com mais de 200 casos semanais entre agosto e setembro. A redução recente deve ser interpretada com cautela, pelo atraso de notificação. A última atualização acrescentou 178 casos, aumento de 4,4% no acumulado. A distribuição é concentrada: Pensilvânia, Carolina do Sul e Utah somam mais da metade dos casos, enquanto o Texas, epicentro em 2025, teve redução de 76%. O CDC contabiliza três óbitos confirmados, número inferior ao divulgado pelos estados por causa da defasagem na confirmação federal. (Figura 22)

A Casos por semana de início do exantema



B Casos por jurisdição

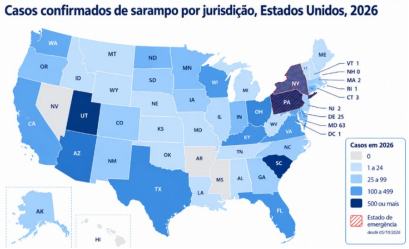


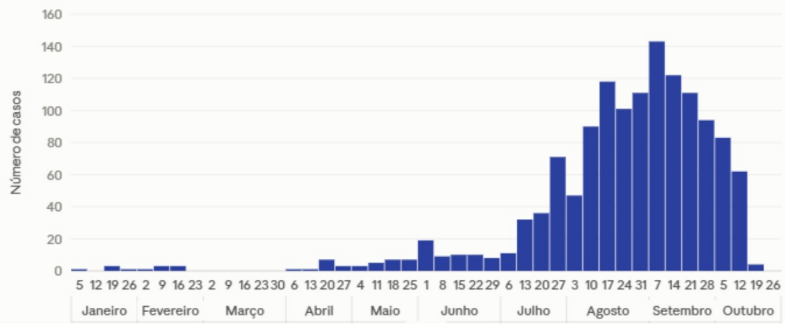
Figura 22. Casos confirmados de sarampo por semana de início do exantema e por jurisdição, Estados Unidos, 2026
Fonte: CDC.

Pensilvânia (EUA) soma 1.338 casos de sarampo e 5 óbitos em 2026, o maior surto do país

1.338	5	255
casos confirmados	óbitos	hospitalizações
alta de 9,5% (116 casos)		

A Pensilvânia concentra o maior surto de sarampo dos Estados Unidos em 2026, com 1.338 casos confirmados pelo Departamento de Saúde estadual até 23 de outubro, cerca de 29% do total nacional. Até junho havia apenas casos esporádicos; a partir de julho a transmissão acelerou, com pico na semana iniciada em 7 de setembro, com quase 140 casos. A última atualização somou 116 casos (alta de 9,5% no acumulado), o maior incremento entre as localidades monitoradas, mas parte relevante deles teve início de sintomas há mais de duas semanas e confirmação tardia, de modo que o aumento não indica necessariamente aceleração da transmissão atual. O estado contabiliza 255 hospitalizações e 5 óbitos, letalidade de cerca de 0,4%. Menos de 1% dos casos ocorreu em pessoas vacinadas, o que indica transmissão predominante entre não vacinados. (Figura 23)

A Casos por semana epidemiológica



B Casos por condado

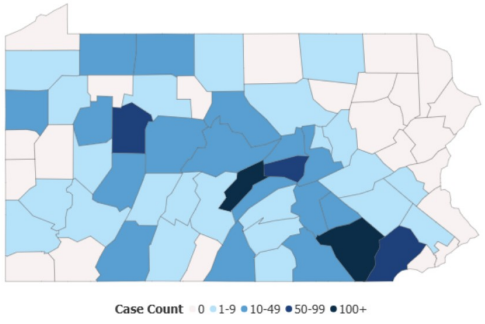


Figura 23. Casos confirmados de sarampo por semana epidemiológica e por condado, Pensilvânia, Estados Unidos, 2026
Fonte: Pennsylvania Department of Health.

México soma 13.722 casos e 23 óbitos por sarampo em 2026, em fase de baixa transmissão

13.722	23	106%
casos confirmados	óbitos, letalidade de 0,17%	de aumento em relação a 2025
alta de 0,2% (31 casos)		

O México acumula 13.722 casos confirmados de sarampo em 2026 e 23 óbitos, com letalidade de 0,17%. O total representa aumento de 106% em relação a 2025, quando foram registrados 6.664 casos. A curva epidêmica atingiu o pico na SE 6, com cerca de 1.200 casos, e desde então apresenta declínio sustentado, com menos de 150 casos semanais a partir da SE 22 e oscilações pontuais nas SE 28, 29 e 35. A última atualização acrescentou 31 casos, incremento de 0,2% no acumulado, o que reforça a fase de baixa transmissão. A incidência municipal é heterogênea: as taxas mais altas se concentram em municípios do norte do país, em especial no estado de Chihuahua, na fronteira com os Estados Unidos. A coexistência de municípios sem casos e de municípios com incidência superior a 29,9 por 100 mil habitantes caracteriza transmissão focal, restrita a comunidades específicas, e não disseminação homogênea no território. (Figura 24)

A Incidência por 100 mil habitantes



B Casos por semana epidemiológica

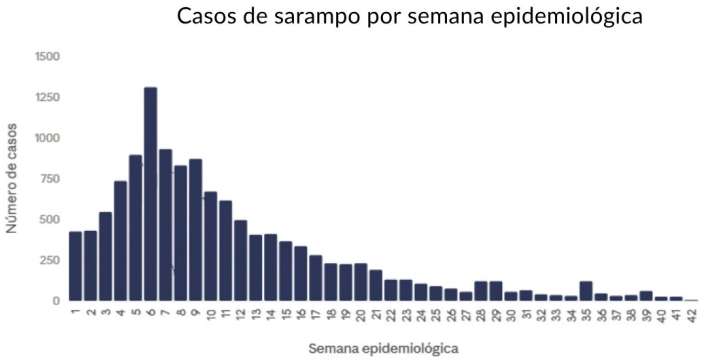


Figura 24. Situação epidemiológica do sarampo no México em 2026
Fonte: Gobierno de México.

Peru registra 2.805 casos de sarampo em 2026, com casos em departamentos da fronteira com o Brasil

2.805	1	> 1.000
casos confirmados	óbito	casos em Puno
alta de 3,5% (96 casos)		

O Peru registra 2.805 casos confirmados de sarampo em 2026 e 1 óbito. A transmissão se intensificou a partir da SE 12 e manteve patamar elevado e sustentado, entre 90 e 155 casos semanais, da SE 20 à 37, com o maior valor na SE 36. A redução nas SE 38 a 40 deve ser interpretada com cautela, pelo atraso de notificação e de confirmação laboratorial. A última atualização acrescentou 96 casos, incremento de 3,5% no acumulado. A maior carga está no sul andino: Puno, que faz divisa com a Bolívia, ultrapassa 1.000 casos, e Arequipa está na faixa de 201 a 999. O dado de maior relevância para o Brasil é a ocorrência de casos em Loreto, Ucayali e Madre de Dios, departamentos amazônicos que fazem fronteira com o Amazonas e o Acre. Loreto integra a tríplice fronteira do Alto Solimões, onde estão Tabatinga e Benjamin Constant. A cronologia é

compatível com a introdução recente do vírus no território brasileiro a partir dessa região, já que os surtos no Amazonas começaram entre as SE 35 e 39, período de maior intensidade da transmissão peruana. (Figura 25)

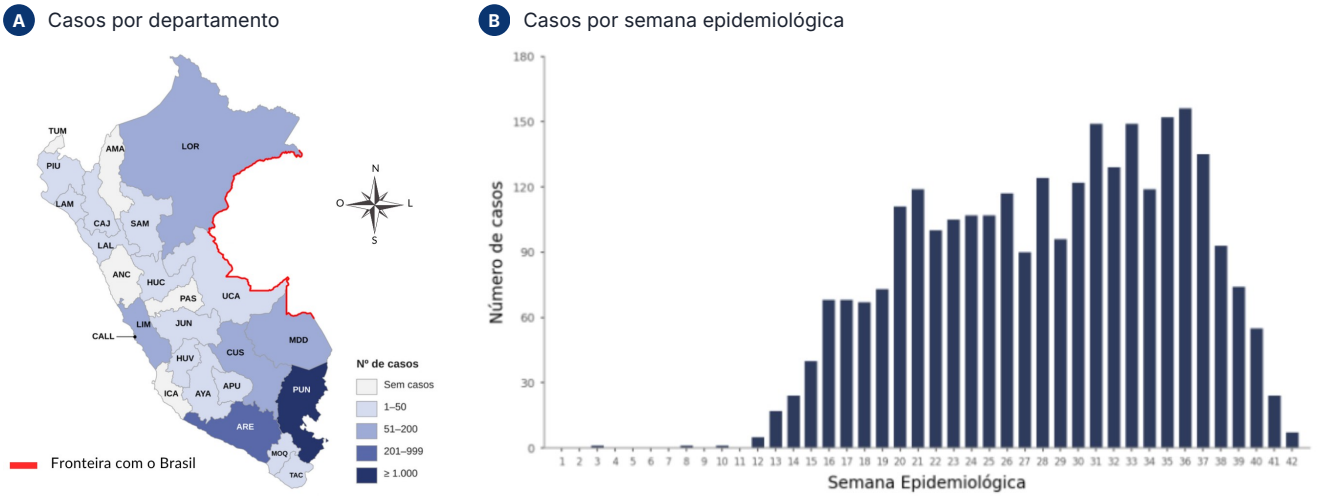


Figura 25. Situação epidemiológica do sarampo no Peru em 2026
Fonte: Ministerio de Salud del Perú.

Nenhuma região do Brasil atinge a meta de 95% de cobertura da segunda dose contra o sarampo em 2026

73,3%	82,2%	97%
menor cobertura da 2ª dose, Região Norte	maior cobertura da 2ª dose, Região Sul	proteção conferida por duas doses

A cobertura vacinal contra o sarampo em 2026 tem comportamento distinto entre as duas doses. Na primeira dose, apenas o Sudeste, com 95,5%, e o Sul, com 96,5%, atingem a meta de 95%; Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam entre 91,4% e 94,7%. Na segunda dose, nenhuma região alcança a meta, com valores entre 73,3%, no Norte, e 82,2%, no Sul. A diferença entre as doses expressa o abandono do esquema vacinal, que chega a cerca de 20% na Região Norte e fica próximo de 15% mesmo nas regiões de melhor desempenho. Como o sarampo tem número básico de reprodução estimado entre 12 e 18, a interrupção da transmissão exige imunidade populacional próxima de 95%. Uma dose confere cerca de 93% de proteção, e duas doses, cerca de 97%; a baixa adesão à segunda dose resulta, portanto, em acúmulo progressivo de suscetíveis a cada coorte de nascidos. A Região Norte reúne as menores coberturas nas duas doses e é justamente onde ocorre o surto mais recente, no Alto Solimões e em Rio Branco. Coberturas regionais elevadas também podem ocultar bolsões municipais de baixa cobertura, nos quais a transmissão se sustenta mesmo com médias satisfatórias. (Tabela 6)

Tabela 6. Cobertura vacinal contra o sarampo por região, Brasil, 2026

REGIÃO	1ª DOSE	2ª DOSE
Norte	91,4%	73,3%
Nordeste	94,2%	79,1%
Centro-Oeste	94,7%	77,2%
Sudeste	95,5%	81,8%
Sul	96,5%	82,2%

Meta de cobertura do PNI: 95%.

6 Ebola

RISCO 4

Humanos e primatas não humanos

República Democrática do Congo acumula 9.704 casos confirmados e 4.687 óbitos por doença pelo vírus Bundibugyo até 23 de outubro de 2026

9.704	4.687	924	80%
casos confirmados	óbitos, letalidade de 48,3%	hospitalizados em isolamento	dos contatos em monitoramento
alta de 4,6%	alta de 4,7%		meta de 95%

A epidemia de doença pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo, declarada pela OMS em 15 de maio de 2026, mantém transmissão sustentada e de alta intensidade. Até 23 de outubro, foram confirmados 9.704 casos e 4.687 óbitos, com letalidade bruta de 48,3%, além de 2.595 recuperados; em relação à semana anterior, os casos cresceram 4,6% e os óbitos, 4,7%. Desde a atualização anterior da OMS, de 8 de outubro, somaram-se 976 casos e 482 óbitos, dos quais 307 ocorreram na comunidade, o que evidencia atraso na detecção e no acesso ao isolamento. É o maior surto de doença pelo vírus Ebola já registrado no país, independentemente da espécie viral, e apenas o segundo causado pelo Bundibugyo, depois do de 2012. Há 924 pacientes hospitalizados em isolamento, e o seguimento diário alcançou 80% dos 30.130 contatos ativos, abaixo da meta de 95%, com o pior desempenho em Kivu do Norte (73,3%). Não há vacina nem tratamento específico licenciados para essa espécie viral; em 23 de outubro começou em Bunia o ensaio clínico de fase 2/3 TUMAINI, que avalia candidatas vacinais contra o Bundibugyo. A OMS classifica o risco como muito alto no país, alto para os países fronteiriços e baixo para o restante da região africana e em nível global. (Figura 26)

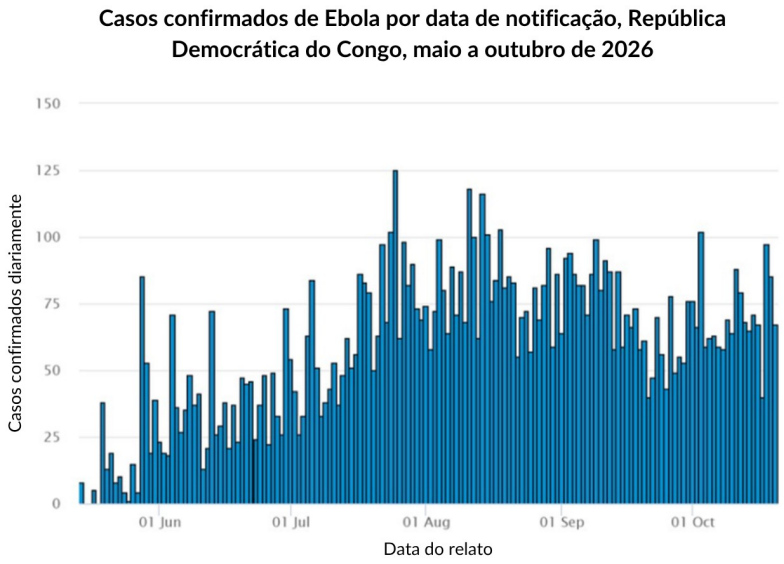


Figura 26. Casos confirmados de Ebola por data de notificação, República Democrática do Congo, maio a outubro de 2026
Fonte: MSPHP (RDC) e OMS.

Surto de Ebola atinge 66 zonas de saúde em oito províncias da República Democrática do Congo até 20 de outubro de 2026

66	8	55,9%
zonas de saúde afetadas	províncias afetadas	letalidade em Kivu do Norte, a maior do país

O surto atinge 66 zonas de saúde em oito províncias, e 50 delas notificaram ao menos um caso nos últimos 21 dias. Ituri permanece como epicentro, com 7.040 casos confirmados e 3.271 óbitos, cerca de 73% dos casos do país, e 28 de suas 36 zonas de saúde afetadas; Mandima, Beni e Bunia concentram a maior carga recente. Kivu do Norte, com 2.146 casos e 1.199 óbitos, cresceu em ritmo semanal duas vezes maior que Ituri e tem a maior letalidade provincial, de 55,9%, o que pode refletir maior proporção de óbitos na comunidade e menor detecção de casos leves. Haut-Uélé e Tshopo seguem com transmissão ativa, e Tshopo teve o maior incremento relativo da semana, de 18,8% nos casos. Nord Ubangi tornou-se a oitava província afetada, com três casos e um óbito, e Dakwa, em Haut-Uélé, é a zona de saúde de introdução mais recente. Bas-Uélé, Kivu do Sul e Sud Ubangi não registraram novos casos no período. O avanço para o norte aproxima a transmissão das fronteiras com a República Centro-Africana e o Sudão do Sul, em um contexto de crise humanitária que dificulta o rastreamento de contatos e o acesso aos serviços de saúde. (Figura 27; Tabela 7)

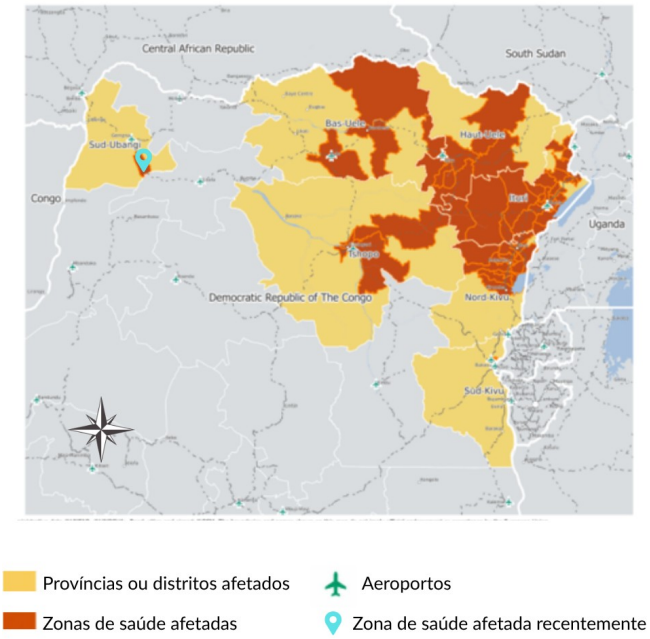


Figura 27. Áreas afetadas pelo surto de Ebola na República Democrática do Congo, outubro de 2026
Fonte: MSPHP (RDC) e ECDC.

Tabela 7. Casos, óbitos e letalidade por Ebola por província, República Democrática do Congo, até 20 de outubro de 2026

PROVÍNCIA	CASOS (VARIAÇÃO)	ÓBITOS (VARIAÇÃO)	LETALIDADE
Ituri	7.040 (3,4%)	3.271 (3,9%)	46,5%
Kivu do Norte	2.146 (7,8%)	1.199 (5,8%)	55,9%
Haut-Uélé	421 (5,8%)	183 (9,6%)	43,5%
Tshopo	76 (18,8%)	27 (12,5%)	35,5%
Bas-Uélé	13	4	30,8%
Kivu do Sul	3	1	33,3%
Sud Ubangi	2	1	50,0%
Nord Ubangi	3 (nova)	1 (nova)	33,3%
Total	**9.704 (4,6%)**	**4.687 (4,7%)**	**48,3%**

Variação percentual em relação à SE anterior; sem variação indicada, sem mudança.

Quênia e Nigéria somam 10 casos de Ebola e 1 óbito fora da República Democrática do Congo em outubro de 2026

10	1	2
casos confirmados fora da RDC	óbito	países: Quênia e Nigéria

Em outubro, a epidemia ultrapassou a República Democrática do Congo, com casos importados no Quênia e na Nigéria, ambos com trânsito pela Uganda em 3 de outubro. No Quênia, o caso índice chegou a Nairóbi por via aérea após cerca de um mês de doença, morreu em 5 de outubro e foi notificado no dia seguinte. Até 22 de outubro, o país somava nove casos e um óbito: o caso índice e oito secundários, quatro familiares e quatro profissionais de saúde, todos já em quarentena ao iniciar os sintomas, o que reduz a probabilidade de cadeias não identificadas. Os 135 contatos foram rastreados, sem evidência de transmissão comunitária. Em 23 de outubro, o Ministério da Saúde do Quênia anunciou um segundo óbito, de uma familiar do caso índice, ainda não incorporado aos informes da OMS e do ECDC. Na Nigéria, o caso de Abuja iniciou sintomas em 7 de outubro, quatro dias após a chegada, buscou atendimento em 11 de outubro e só foi confirmado em 20 de outubro. Esse intervalo de nove dias entre o atendimento e a confirmação amplia a janela de exposição em serviços de saúde; 44 contatos estão em monitoramento. A OMS mantém a recomendação contra restrições de viagem e comércio. (Figura 28)

03/10 — Os dois casos transitam pela Uganda

06/10 — Quênia notifica o 1º caso, já em óbito

07/10 — Início de sintomas na Nigéria

20/10 — Nigéria confirma o caso

20/10 — Quênia chega a 9 casos

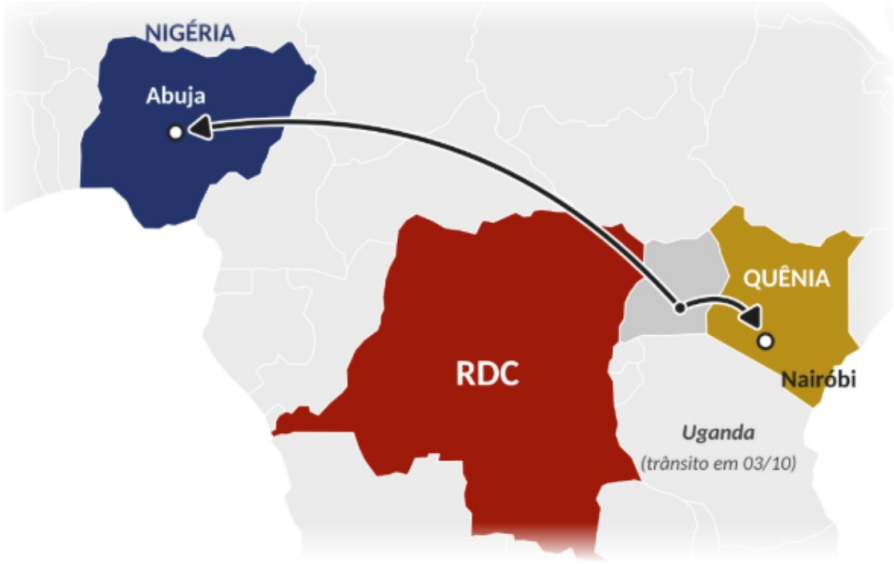


Figura 28. Casos de Ebola fora da República Democrática do Congo, outubro de 2026
Fonte: MSPHP (RDC) e OMS.

7 Atualidades

França notifica o primeiro caso humano de infecção pelo vírus Shamonda no mundo em outubro de 2026

1º

caso humano de infecção pelo vírus Shamonda no mundo

52

departamentos franceses com bovinos infectados, em 20/10

Enquanto o cenário internacional exige atenção a emergências infecciosas como o Ebola na República Democrática do Congo, a identificação de novos eventos de transmissão de patógenos de animais para humanos também merece destaque. Em outubro de 2026, a França notificou o primeiro caso humano documentado de infecção pelo vírus Shamonda, até então conhecido principalmente pela circulação em animais. O vírus pertence ao gênero Orthobunyavirus, do sorogrupo Simbu, a mesma família do vírus Oropouche, e está associado a infecções em ruminantes, nos quais pode causar febre, redução da produção de leite, abortos e malformações. A transmissão ocorre principalmente pela picada de insetos do gênero Culicoides (mosquito-pólvora). O paciente, um homem imunocomprometido que trabalhava no manejo de bovinos na região de Lyon, morreu no início de outubro; o caso foi notificado em 7 de outubro e divulgado pelo ECDC e pela OMS em 22 de outubro, e a contribuição da infecção para o óbito ainda depende dos resultados da investigação. Em 20 de outubro, havia bovinos infectados em 52 departamentos franceses, e a hipótese principal é a picada de Culicoides, sem transmissão entre pessoas. O caso reforça a importância de monitorar eventos de spillover, a transmissão de agentes infecciosos entre espécies, que podem representar etapas iniciais da emergência de zoonoses. Sob a perspectiva de Saúde Única, a integração entre as vigilâncias humana, animal e ambiental é essencial para detectar precocemente esses eventos e orientar medidas de prevenção e controle. (Figura 29)



Figura 29. Local de ocorrência do caso humano de infecção pelo vírus Shamonda, região de Lyon, França, outubro de 2026
Fonte: ECDC.

NOTA METODOLÓGICA

Boletim referente à SE 42/2026 (18 a 24 de outubro de 2026), elaborado a partir do relatório de situação (SITREP) semanal. As figuras reproduzem os painéis do relatório, com as fontes indicadas em cada uma. Os dados são preliminares e estão sujeitos a alteração; para uso técnico, consulte sempre a fonte original indicada.

ELABORAÇÃO

Alerta ambiental	Gustavo Manço
Síndrome gripal	Anna Karolina
SRAG	Anna Karolina
Imunopreveníveis	Antonia Santos
Arboviroses	Sérgio Alves
Sarampo	Antonia Santos
Ebola	Vitória Chagas
Atualidades	Bárbara e Layanne
Revisão	Clara Feitosa, Jonas Brant

REALIZAÇÃO

Sala de Situação de Saúde - UnB
Residência de Vigilância em Saúde